

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO DE PROBLEMAS INTERPERSONALES — FORMA BREVE (IIP-32)

Eje II: Procesos Psicológicos • Modelo Circumplejo Interpersonal (IPC) y Evaluación del Distrés Relacional

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario de Problemas Interpersonales — Forma Breve (IIP-32).
Nombre Original (Inglés)	<i>Inventory of Interpersonal Problems - Short Form (IIP-32)</i>
Autores del IIP-32	Drs. Michael Barkham, Gillian E. Hardy y Shirley Startup (1996).
Autores de la Escala Matriz	Drs. Leonard M. Horowitz, S. E. Rosenberg, B. A. Baer, G. Ureño y V. Villaseñor (1988, 2000).
Validaciones Hispánicas	Gómez Penedo, Fernández-Álvarez, Maristany & Freiberg Hoffmann (2022); Cifuentes et al.
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo Circumplejo Interpersonal (IPC), Vínculos y Asertividad.
Tipo de Instrumento	Autoinforme dimensional de 32 reactivos estructurados en 8 octantes (escala Likert 0 a 4).
Población y Rango	Adultos y jóvenes (desde 16 años). Pacientes clínicos en psicoterapia individual y de pareja.
Tiempo de Administración	6 a 8 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Instrumento científico para uso clínico y de investigación académica bajo citación formal.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO CIRCUMPLEJO DE HOROWITZ Y LEARY

El IIP-32 se fundamenta en la tradición interpersonal de Harry Stack Sullivan (1953) y el modelo del Circumplejo Interpersonal (IPC) desarrollado por Timothy Leary (1957), operacionalizado rigurosamente por Leonard Horowitz y Jerry Wiggins. El marco conceptual postula que la mayor parte de las dificultades psicopatológicas y quejas asistenciales se originan, expresan y mantienen en el ámbito de las interacciones interpersonales cotidianas.

El espacio relacional humano está gobernado por dos dimensiones axiales ortogonales:

1. **Agencia / Dominancia vs. Sumisión (Eje Vertical):** Grado de poder, control, asertividad e influencia social ejercido en las relaciones.
2. **Comunión / Afiliación vs. Frialdad (Eje Horizontal):** Grado de calidez, empatía, amor y cooperación afectiva frente al distanciamiento hostil.

La intersección circular de ambos ejes produce 8 cuadrantes u octantes clínicos específicos que describen conductas interpersonales que al sujeto “le cuesta hacer” (inhibiciones) o conductas que “hace en exceso” (compulsiones relacionales). Neurobiológicamente, el distrés interpersonal crónico refleja alteraciones en la red de cognición social y mentalización (corteza prefrontal medial, unión temporoparietal y precúneo), unida a una hiperreactividad insular y cingulada ante claves de juicio ajeno.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE LOS 8 OCTANTES (4 ÍTEMS C/U)

Octante del Circumplejo	Código	Nº Ítems	Definición Operativa y Estilo Disfuncional Evaluado
1. Dominante / Autoritario	PA	4 ítems	Dificultad para ceder control; tendencia a manipular, imponerse y mandar a otros.
2. Vindictivo / Desconfiado	BC	4 ítems	Rencor perseverante, hostilidad defensiva y desconfianza en intenciones ajenas.
3. Frío / Distante	DE	4 ítems	Incapacidad para expresar afecto íntimo, ternura y conectar emocionalmente.
4. Socialmente Evitativo	FG	4 ítems	Timidez severa, incomodidad en grupos y dificultad para iniciar interacciones.
5. No Asertivo / Sumiso	HI	4 ítems	Incapacidad para defender derechos, expresar disgustos o decir «no».
6. Explotable / Complaciente	JK	4 ítems	Permisividad extrema; dejarse manipular por miedo a ser rechazado.
7. Excesivamente Nutricio	LM	4 ítems	Cuidado compulsivo de los demás con descuido flagrante del propio bienestar.
8. Intrusivo / Demandante	NO	4 ítems	Invasión de límites ajenos, necesidad excesiva de atención y protagonismo.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión global: alfa de Cronbach de la escala total (Distrés Global) de 0.88 a 0.93 en muestras hispanas clínicas y comunitarias (Gómez Penedo et al., 2022). Los 8 octantes presentan alfas entre 0.70 y 0.84. Fiabilidad test-retest $r = 0.80$ a 4 semanas.
Estructura Circumpleja	El Análisis Factorial Confirmatorio y las pruebas de ajuste circular ratifican la disposición espacial armónica de los 8 octantes alrededor de los ejes de Agencia y Comunión ($CFI = 0.93$, $TLI = 0.91$, $RMSEA = 0.048$), confirmando la validez del modelo circumplejo.
Validez Concurrente y Clínica	Correlación directa elevada con síntomas del SCL-90-R y BDI-II ($r = 0.54$). Los octantes muestran correlaciones diagnósticas específicas con los Trastornos de la Personalidad del DSM-5: HI y JK con Dependiente; FG con Evitativo; DE con Esquizoide; PA y BC con Límite y Antisocial.
Sensibilidad al Cambio en Psicoterapia	El IIP-32 es el instrumento predilecto a nivel internacional para evaluar el cambio estructural en psicoterapias individuales, dinámicas y de grupo, registrando reducciones de gran tamaño de efecto ($d > 0.85$).
Invarianza Transcultural	Equivalencia métrica verificada entre adaptaciones británicas, españolas y latinoamericanas; las mujeres presentan puntuaciones superiores en octantes complacientes (JK/LM) y varones en dominancia y frialdad (PA/DE).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 32 ítems se responde en escala Likert de 5 puntos (**0** = «Nada en absoluto», **1** = «Ligeramente», **2** = «Moderadamente», **3** = «Mucho», **4** = «Extremadamente»):

- **Paso 1 (Cálculo Directo sin Inversión):** Todos los reactivos son directos en sentido del malestar evaluado.
- **Paso 2 (Puntuación Media por Octante):** Se promedian los 4 reactivos de cada octante: $\text{Media Octante} = \frac{\sum_{i=1}^4 \text{ítem}_i}{4}$. Rango: **0.00 a 4.00 puntos**.
- **Paso 3 (Puntuación Media Global IIP-32 - Nivel General de Distrés Interpersonal):** Promedio aritmético de los 32 reactivos. Rango: **0.00 a 4.00 puntos**. A mayor puntuación, mayor sufrimiento y conflictividad relacional.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y BAREMOS INTERPRETATIVOS (GÓMEZ PENEDO ET AL., 2022)

Estratificación	Media Global	Nivel de Distrés Relacional	Conducta Asistencial Recomendada
No Clínico	0.00 a 1.00	Ajuste interpersonal armónico	Habilidades sociales adaptativas; capacidad para equilibrar asertividad y calidez afectiva.
Moderado	1.01 a 1.50	Distrés reactivo o situacional	Dificultades interpersonales en contextos de estrés laboral o de pareja; abordaje psicoeducativo.
Clínico	1.51 a 2.20	Disfunción interpersonal manifiesta (corte ≥ 1.51)	Patrón desadaptativo consolidado. Interferencia relacional clara. Indicación formal de psicoterapia.
Severo Grave	/ 2.21 a 4.00	Disfunción interpersonal severa / TLP	Graves conflictos vinculares crónicos, aislamiento o relaciones caóticas. Abordaje intensivo.

EL VECTOR CIRCUMPLEJO: ELEVACIÓN VS. POLARIZACIÓN:

La interpretación del IIP-32 debe analizar dos componentes: (1) el **Nivel General de Distrés** (la elevación media del círculo, indicativa de malestar general) y (2) la **Polaridad del Vector Interpersonal** (el octante que sobresale nítidamente por encima de los demás). Un paciente con vector dominante en HI (No Asertivo) requerirá entrenamiento en firmeza, mientras que uno con vector dominante en BC (Vindicativo) requerirá desescalada hostil y mentalización.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN DIFICULTADES INTERPERSONALES (IPC)

PROTOCOLO CLÍNICO BASADO EN EL PERFIL CIRCUMPLEJO DEL IIP-32:

- **Paso 1 (Representación Gráfica del Circumplejo):** Plotear las medias de los 8 octantes en la diana interpersonal. Localizar el foco de disfunción primaria: Hemisferio Sumiso (FG, HI, JK) vs. Hemisferio Hostil/Dominante (PA, BC, DE).
- **Paso 2a (Abordaje del Hemisferio Sumiso-Complaciente):** Si predominan HI/JK, entrenamiento asertivo, establecimiento de límites firmes, desmantelamiento de la necesidad de aprobación compulsiva y exposición a la discrepancia.
- **Paso 2b (Abordaje del Hemisferio Frío-Hostil):** Si predominan BC/DE, entrenamiento en empatía, expresión emocional de vulnerabilidad y terapia focalizada en la transferencia para reparar la desconfianza vincular.
- **Paso 3 (Monitorización):** Un descenso en el Distrés Global de ≥ 0.40 puntos y redondeo armónico del perfil confirman remisión relacional.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN ANSIEDAD SOCIAL Y NO ASERTIVIDAD

Identificación: Varón de 34 años, analista de sistemas, acude por quejas de tensión crónica en el trabajo, sensación de que “mis compañeros abusan de mí y me cargan de tareas que no me corresponden” e incapacidad absoluta para negarse.

Evaluación Inicial IIP-32 (Línea Base): Puntuación Media Global = **1.94/4.00** (Rango Clínico Elevado). Perfil polarizado en el cuadrante inferior derecho: No Asertivo (HI) = **3.75/4.00** (Extremo); Explotable/Complaciente (JK) = **3.50/4.00**; Socialmente Evitativo (FG) = **2.75/4.00**. Por el contrario, Dominante (PA) = 0.25 y Vindicativo (BC) = 0.50.

Intervención Implementada: 14 sesiones de psicoterapia cognitivo-conductual e interpersonal. Se realizaron role-plays de ensayo de conducta para decir “no” sin justificaciones excesivas, reestructuración del miedo catastrófico al enfado ajeno y asignación de tareas asertivas graduadas en la oficina.

Reevaluación a las 14 Semanas: Distrés Global descendió a **0.92/4.00** (retorno al Rango No Clínico / Ajustado). No Asertivo bajó a **1.25/4.00** (-2.5 pts) y Explotable a **1.00/4.00** (-2.5 pts). El paciente logró redistribuir equitativamente las tareas de su equipo y comunicó un incremento sustancial en satisfacción vital.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

RIESGO DE RUPTURA DE LA ALIANZA:

Pacientes con elevaciones extremas en el octante Vindicativo/Desconfiado (BC) o Frío (DE) tienden a proyectar hostilidad y desconfianza hacia el terapeuta desde las primeras entrevistas. Exige prestar atención extrema a la metacomunicación y encuadre.

DISTINCIÓN CON TRASTORNO DE PERSONALIDAD:

Una elevación generalizada extrema en todos los octantes (perfil inflado) orienta hacia un Trastorno de la Personalidad Límite o descompensación psicopatológica aguda. Contrastar siempre con entrevistas diagnósticas estructuradas (SCID-5-PD).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Barkham, M., Hardy, G. E., & Startup, S. (1996). The IIP-32: A short form of the Inventory of Interpersonal Problems. *British Journal of Clinical Psychology*, 35(1), 21-35.
2. Horowitz, L. M., Alden, L. E., Wiggins, J. S., & Pincus, A. L. (2000). *Inventory of Interpersonal Problems manual*. The Psychological Corporation.
3. Gómez Penedo, J. M., Fernández-Álvarez, A., Maristany, M., & Freiberg Hoffmann, A. (2022). Evidencias psicométricas de la versión argentina del Inventario de Problemas Interpersonales (IIP-32). *Revista Evaluar*, 22(2), 64-75.
4. Horowitz, L. M., Rosenberg, S. E., Baer, B. A., Ureño, G., & Villaseñor, V. S. (1988). Inventory of Interpersonal Problems: Psychometric properties and clinical applications. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 56(6), 885-892.